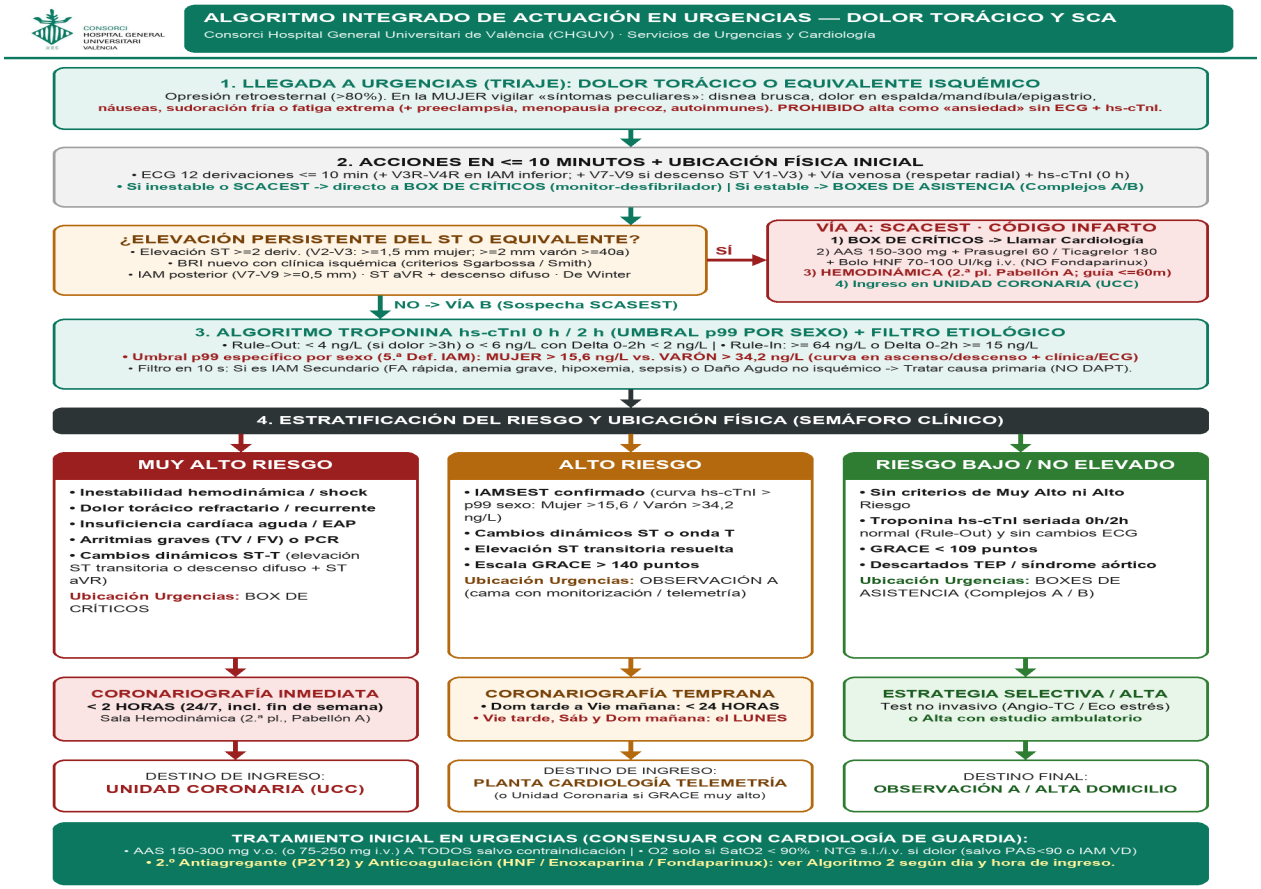
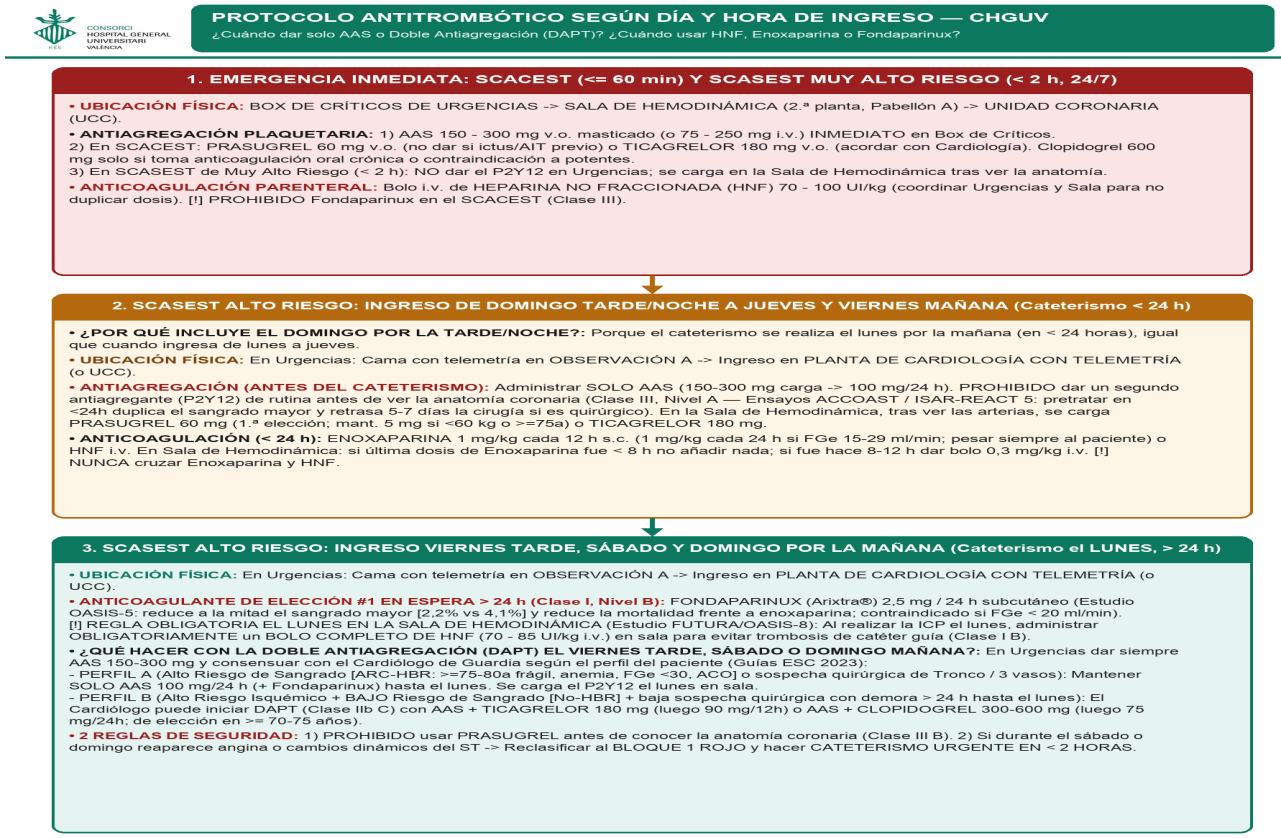
GUÍA OPERATIVA INTEGRADA DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS Y CARDIOLOGÍA: DOLOR TORÁCICO Y SCA

Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) · Resumen Ejecutivo de Acceso Inmediato (Semáforo Clínico, Ubicación y Fármacos)

SEMÁFORO Y ESCENARIO	UBICACIÓN FÍSICA CHGUV	FÁRMACOS EN URGENCIAS	ANTICOAGULACIÓN Y 2.º ANTIAGREGANTE
ROJO — 1A. SCACEST o Equivalente Código Infarto (ICP < 90 min)	**BOX DE CRÍTICOS → SALA HEMODINÁMICA → UCC**	• **SOLO AAS 300 mg** v.o. (o 150-250 mg i.v.).	• **En Sala de Hemodinámica:** Bolo de HNF y 2.º antiagregante (no poner en Urgencias para evitar dobles dosis).
ROJO — 1B. SCASEST MUY ALTO RIESGO Inestable, dolor refractario, EAP, TV/FV	**BOX DE CRÍTICOS / OBS. A → SALA HEMODINÁMICA (< 2 h) → UCC**	• **SOLO AAS 300 mg**.	• **En Sala de Hemodinámica:** Anticoagulación i.v. y 2.º antiagregante tras ver anatomía.
ÁMBAR — 2A. IAMSEST (curva aguda) o Angina Inestable (3 criterios) Barthel ≥ 30	Monitorizar en **OBSERVACIÓN A** y comentar con Cardiólogo → **PLANTA TELEMETRÍA / UCC**	• **SOLO AAS 300 mg**.	• **Protocolo UCO CHGUV al ingreso:** Fondaparinux (**Arixtra®**) 2,5 mg/24h s.c. El 2.º antiagregante solo se da cuando actúa como puente.
VERDE — 2B. SCASEST en > 80 años con Barthel < 30 Dependencia severa sin elevación ST	**Observación de Urgencias durante 5 h** → Si sin angina tras 5 h: **ALTA DESDE URGENCIAS**	• **AAS + Clopidogrel** + Bisoprolol o Amlodipino + parche **NTG 5 mg**.	• Manejo conservador al alta sin ingreso en Cardiología ni anticoagulación parenteral de puente.
VERDE — 3. BAJO RIESGO / BASAL PLANA hs-cTnI ≤ p99 o plana (Δ < 20%) sin Angina Inestable	**BOXES GENERALES URGENCIAS** → Alta / Manejo por Urgencias (NO llamar a Cardiología)	• No precisa antiagregación aguda.	• No precisa anticoagulación.



Algoritmo 1 (CHGUV): Actuación integrada en Urgencias ante Dolor Torácico, diagnóstico diferencial por sexo y Semáforo de Riesgo.



Algoritmo 2 (CHGUV): Protocolo antitrombótico exacto según día y hora de ingreso (Domingo tarde a Viernes mañana vs. Viernes tarde, Sábado y Domingo mañana).

PASO 0 (FILTRO PREVIO OBLIGATORIO): TROPONINA ELEVADA SIN DOLOR TORÁCICO -> NO ES UN SCA TIPO 1

• **Regla de Oro CHGUV (5.ª Definición Universal de IAM y Guías ESC 2023):** Si el paciente **NO consulta por dolor torácico ni clínica anginosa** y presenta una **hs-cTnI > p99** (Mujer > 15,6 / Hombre > 34,2 ng/L) con ECG sin elevación del ST, se trata de un **Daño Miocárdico No Isquémico** o un **IAM Tipo 2**, **NUNCA de un SCA aterotrombótico (Tipo 1)**. En estos casos está **PROHIBIDO iniciar Doble Antiagregación (DAPT)** (multiplica el sangrado grave) y **NO se debe llamar de rutina al Cardiólogo de Guardia**.

Contexto Clínico (Sin Dolor Torácico)	Mecanismo (5.ª Def. IAM)	Qué Valorar y Hacer (Sin Activar Protocolo SCA)
1. Taquiarritmia (FA rápida, TSV) o bradiarritmia	IAM Tipo 2 / Daño secundario	Controlar FC o revertir arritmia y repetir ECG tras frenar FC. **NO dar DAPT ni pedir cateterismo urgente.**
2. Sepsis, Neumonía, EPOC agudizado o Hipoxemia	Daño Miocárdico Agudo / IAM Tipo 2	Oxigenoterapia, antibioterapia precoz y soporte hemodinámico. Contraindicada DAPT y heparina de SCA.
3. Insuficiencia Cardíaca Aguda / EAP	Daño Miocárdico por sobrecarga parietal	Diuréticos i.v., vasodilatadores, NT-proBNP y ecocardiograma reglado sin activar circuito de SCASEST.
4. Anemia severa, Hemorragia, Hipotensión o Crisis HTA	IAM Tipo 2 (desajuste oferta/demanda)	Transfundir si anemia, controlar sangrado o PA. **¡Dar DAPT o heparina agravará cualquier sangrado!**
5. Enfermedad Renal Crónica (ERC) / Cardiopatía previa	Daño Miocárdico Crónico (Δ < 20%)	Comparar con basales previas. Si variación 0h/2h < 20% sin dolor ni cambios ECG, descartar evento agudo.
6. TEP, Ictus agudo, Síncope o Rabdomiólisis	Daño Miocárdico Agudo no coronario	Si disnea/taquicardia → Dímero D / Angio-TC pulmonar (TEP). Si ictus → manejo neurológico sin DAPT de SCA.

PASO 1 Y 2: PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO -> PARTICULARIDADES EN LA MUJER, ANGINA Y ESCALAS

• **Clínica de sospecha en la Mujer y en el Hombre:** El dolor opresivo retroesternal es el síntoma principal en ambos sexos, pero en la mujer se acompaña con alta frecuencia de irradiación a espalda interescapular, mandíbula, cuello o epigastrio, disnea brusca, náuseas, sudoración fría o fatiga extrema. En mujeres ≤ 55 años o en el periparto, sospechar siempre **Disección Coronaria Espontánea (SCAD)**. Aplicar siempre el umbral p99 de hs-cTnI específico por sexo: **Mujer > 15,6 ng/L** y **Hombre > 34,2 ng/L**.

• **Definición de Angina Típica y Angina Inestable:** La Angina Típica cumple 3 criterios: 1) Opresión/peso retroesternal; 2) Provocada por esfuerzo o estrés (o en reposo > 20 min); 3) Cede con reposo o NTG sublingual en < 5 min. Es **Angina Inestable** cuando aparece en reposo (> 20 min), es de reciente comienzo (*de novo*) o progresiva (*in crescendo*).

• **Regla Institucional en Dolor Torácico con Troponinas Negativas:** Un dolor torácico con hs-cTnI 0h/2h negativa y ECG normal **NUNCA ingresa solo por el GRACE** (la edad y la creatinina elevan el GRACE > 140 en ancianos sin SCA). Además, **Urgencias no ingresa directamente en Cardiología**: todo caso se comenta con el **Cardiólogo de Guardia**.

LOS 3 CRITERIOS OFICIALES DE ANGINA INESTABLE EN URGENCIAS (CHGUV) Y CASOS DE DECISIÓN

Criterio de Angina Inestable en Urgencias (CHGUV)	Definición Clínica Operativa (Descartadas Otras Causas de Clínica Anginosa)
Criterio 1 (In crescendo / Reposo recurrente)	Dolor torácico opresivo de repetición (**> 1 episodio**) con disminución del umbral de esfuerzo de aparición o con clínica en reposo.
Criterio 2 (Reciente comienzo / De novo)	Dolor torácico opresivo de repetición con los esfuerzos (o estrés emocional) de inicio hace **menos de 2 meses**.
Criterio 3 (Episodio único típico completo)	Único episodio de dolor torácico con **múltiples características anginosas simultáneas**: opresivo + irradiación a miembros superiores, mandíbula o región interescapular + **cortejo vegetativo asociado** (sudoración fría, náuseas/vómitos o disnea súbita).
■ **Matiz Clínico en la Mujer (ESC)**	En la mujer el dolor opresivo retroesternal asocia con alta frecuencia irradiación a **región interescapular (espalda), mandíbula, cuello o epigastrio** y cortejo de **disnea brusca, náuseas o fatiga extrema**. En ≤ 55 años / periparto sospechar **SCAD**.

Caso Clínico en Urgencias	Hallazgo en hs-cTnI 0h/2h y Clínica	Conducta Operativa en el CHGUV
CASO 1: hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 sin criterios de Angina Inestable	Rule-Out ESC 0h/2h + no cumple los 3 criterios de angina	• **ALTA DIRECTA SEGURA** desde Boxes Generales de Urgencias (NO llamar a Cardiología).
CASO 2: hs-cTnI discretamente elevada pero PLANA (ej. 24 → 26 ng/L)	Variación 0h/2h < 20% (Δ < 5 ng/L) + ECG normal + sin Angina Inestable	• Elevación basal crónica estable (edad, HTA, HVI o función renal). **NO pedir 3.ª troponina ni llamar al Cardiólogo de Guardia** → Alta / manejo por Urgencias.
CASO 3: Angina Inestable (Criterio 1, 2 o 3) o IAMSEST (curva aguda)	Cumple 1 de los 3 criterios de Angina Inestable o curva aguda (Δ ≥ 20%)	• Si Barthel ≥ 30: Administrar **AAS 300 mg**, pasar a Observación A y **comentar con el Cardiólogo de Guardia** (al ingreso: **Arixtra 2,5 mg s.c.** según protocolo UCO).
CASO 4: SCASEST en > 80 años con Índice de Barthel < 30	Dependencia severa sin elevación del ST y sin angina tras 5 h	• Tras **5 h de observación sin angina** → **Alta desde Urgencias** con **AAS + Clopidogrel + Bisoprolol/Amlodipino + parche NTG 5 mg** (evitando ingresos fútiles).

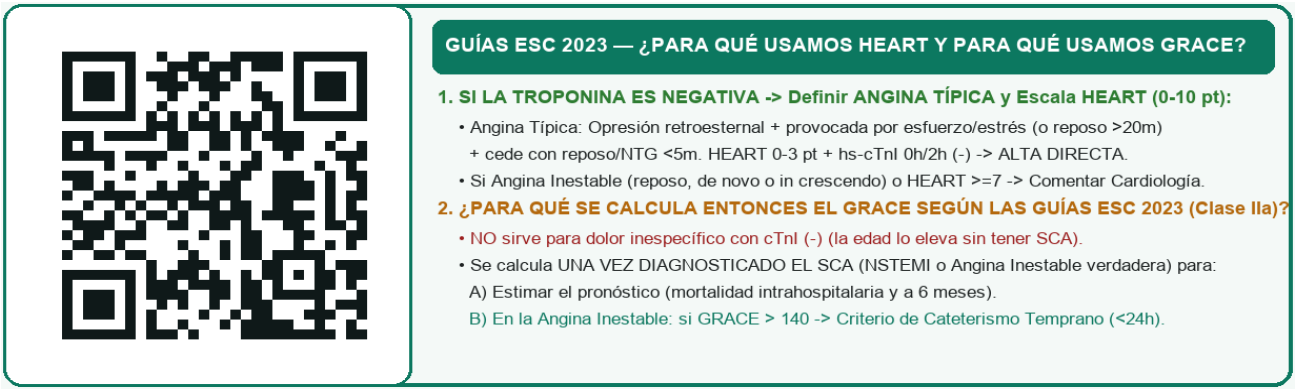


Figura 1B: Diferenciación práctica entre Escala HEART (troponina negativa) y Escala GRACE (SCA / Angina Inestable diagnosticada) con código QR.

PASO 5: GUÍA DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA DEL PROTOCOLO SCA CHGUV

• **Filtrado Progresivo Inteligente (Izquierda y Derecha sin Ruido Visual):** Al seleccionar el sexo biológico (Mujer vs. Hombre), el grupo de edad (< 75 vs. ≥ 75 años), el ECG y la situación clínica, desaparecen automáticamente tanto en el panel izquierdo como en el derecho todas las opciones, preguntas de troponinas/deltas y notas de fármacos que no corresponden a ese paciente.

• **Cuatro Pestañas Integradas: 1) Decisión Interactiva** (ubicación física en el CHGUV, dosis exacta de AAS/P2Y12/Fondaparinux/Enoxaparina/HNF y generador de nota clínica para copiar); **2) Escalas HEART y GRACE** (calculadoras interactivas conectadas al algoritmo); **3) Tabla Rápida de Guardia**; y **4) Descarga de Documentos PDF** (Protocolo Completo en PDF y Presentación Clínica en PDF).

• **Aviso Clínico (Disclaimer):** La aplicación y este protocolo tienen carácter orientativo basado en las Guías ESC 2023 y no sustituyen el juicio clínico individualizado del facultativo ni el comentario directo con el Cardiólogo de Guardia.